BULLETIN HEBDOMADAIRE · CENTRE DE CARDIOLOGIE DE RODEZ

PAUSE CARDIO ❤

Nouveautés de la semaine du 6 novembre 2026

10 nouveautés cette semaine, dont 2 susceptibles de changer votre pratique.

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL **Changement de pratique** Essai randomisé · PROGRESS

TAVR in Patients with Moderate Aortic Stenosis with At-Risk Features.

NEJM · 2 novembre 2026 · Essai randomisé ouvert de supériorité, 744 patients, international · TCT 2026

Cet essai randomisé ouvert international a comparé le TAVI transfémoral avec une valve à expansion par ballonnet et la surveillance clinique chez 744 patients porteurs d'une sténose aortique modérée (surface moyenne 1,2 cm², vitesse maximale moyenne 3,3 m/s) avec au moins un critère de risque, c'est-à-dire un symptôme ou une anomalie structurelle ou fonctionnelle associée à une progression plus rapide ou à un pronostic défavorable. À deux ans, le critère principal associant décès toutes causes et événement d'insuffisance cardiaque, avec ou sans hospitalisation, est survenu chez 16,7 % des patients du groupe TAVI contre 23,9 % sous surveillance (différence de risque −7,2 points ; IC95 % −13,1 à −1,3 ; p = 0,02). La différence tient aux événements d'insuffisance cardiaque (10,8 % contre 19,0 %), la mortalité toutes causes étant voisine dans les deux groupes (8,4 % contre 7,3 %).

> **En pratique :** chez le patient porteur d'une sténose aortique modérée qui présente un symptôme ou une anomalie structurelle ou fonctionnelle de mauvais pronostic, cet essai montre qu'un TAVI d'emblée réduit de 7,2 points, en valeur absolue, le critère associant décès et événements d'insuffisance cardiaque à deux ans, et c'est aux événements d'insuffisance cardiaque évités que tient l'essentiel du bénéfice. La mortalité n'est pas modifiée à deux ans, l'essai était ouvert et financé par le fabricant, et la durabilité au-delà de deux ans reste inconnue. Les recommandations actuelles préconisent la surveillance dans la sténose modérée : ce résultat ouvre la discussion pour les patients à risque et à anatomie favorable, sans s'étendre à l'ensemble des sténoses modérées.

Article original · Analyse TCTMD

RYTHMOLOGIE **Changement de pratique** Essai randomisé · SIMPLAAFY

Antithrombotic Therapy After Left Atrial Appendage Occlusion: The SIMPLAAFY Randomized Clinical Trial.

JAMA · 2 novembre 2026 · Essai randomisé de non-infériorité en ouvert, 1 857 patients, 87 centres américains · TCT 2026

Cet essai randomisé de non-infériorité, en ouvert, mené dans 87 centres américains, a comparé trois schémas antithrombotiques après fermeture percutanée réussie de l'auricule gauche chez 1 857 patients en fibrillation atriale non valvulaire : bithérapie antiplaquettaire pendant 6 mois puis aspirine, AOD à dose réduite pendant 3 mois puis aspirine, ou aspirine seule pendant 12 mois. À 6 mois, le critère composite associant décès, AVC, embolie systémique et saignement majeur est survenu chez 6,9 % des patients sous bithérapie, 5,1 % sous AOD à dose réduite et 3,3 % sous aspirine seule, et les deux monothérapies ont atteint la non-infériorité (p < 0,001 pour chacune). Les saignements majeurs étaient moins fréquents sous aspirine seule (1,7 %) et sous AOD à dose réduite (2,7 %) que sous bithérapie (4,5 %).

> **En pratique :** après une fermeture percutanée de l'auricule gauche sans complication, l'aspirine seule ou un AOD à dose réduite pendant 3 mois ne font pas moins bien que la bithérapie antiplaquettaire à 6 mois ; les saignements majeurs ont été moins fréquents, mais cette comparaison reste exploratoire. Ces résultats permettent d'envisager un schéma plus léger après une implantation sans complication, chez des patients comparables à ceux inclus. Le suivi de 6 mois et la rareté des AVC ne permettent pas de conclure sur le risque thromboembolique à plus long terme, et la fréquence plus faible du thrombus sur dispositif sous AOD à dose réduite reste une observation exploratoire.

Article original

CARDIOMYOPATHIES & MYOCARDITES À connaître Suivi à long terme · HELIOS-B

Long-Term Impact of Vutrisiran in Patients With TTR Amyloidosis With Cardiomyopathy: 1-Year Efficacy and Safety Outcomes From the HELIOS-B Open-Label Extension.

Circulation · 3 novembre 2026 · Extension en ouvert d'un essai randomisé, 466 patients, suivi jusqu'au mois 48

Cette extension en ouvert de l'essai HELIOS-B a suivi jusqu'au mois 48 les patients atteints d'amylose à transthyrétine avec cardiomyopathie qui avaient achevé la phase en double aveugle de 33 à 36 mois : 466 des 654 participants y sont entrés, ceux du groupe vutrisiran poursuivant le traitement (243 patients) et ceux du groupe placebo le débutant (223). Par rapport aux patients passés du placebo au vutrisiran, le vutrisiran continu a été associé à une réduction de 37 % du risque de décès ou de premier événement cardiovasculaire (HR 0,63 ; IC95 % 0,51–0,79 ; p = 0,0001) et de 37 % de la mortalité toutes causes (HR 0,63 ; IC95 % 0,46–0,84 ; p = 0,0023), avec une meilleure qualité de vie et des biomarqueurs plus bas. Aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé ; l'écart en faveur du traitement commencé d'emblée ne s'est pas comblé après un an de vutrisiran chez les anciens patients sous placebo.

> **En pratique :** chez le patient atteint d'amylose à transthyrétine avec cardiomyopathie, le bénéfice du vutrisiran sur la mortalité, les événements cardiovasculaires, la qualité de vie et les biomarqueurs se maintient jusqu'à quatre ans, sans nouveau signal de sécurité. Les patients qui n'ont commencé le traitement qu'après trois ans de placebo gardent un pronostic moins bon que ceux traités d'emblée, ce qui plaide pour un diagnostic et un traitement précoces. Cette comparaison provient toutefois d'une phase en ouvert, chez des patients sélectionnés par leur survie à la première phase, et n'a pas la force d'une comparaison en double aveugle contre placebo.

Article original

INSUFFISANCE CARDIAQUE À connaître Essai randomisé · H-HeFT

Hydralazine-isosorbide dinitrate in chronic heart failure with reduced ejection fraction: the H-HeFT trial.

European Heart Journal · 4 novembre 2026 · Essai randomisé en double aveugle contre placebo, 592 patients, 23 hôpitaux danois

Cet essai randomisé en double aveugle, mené dans 23 hôpitaux danois, a comparé l'association hydralazine–dinitrate d'isosorbide à un placebo chez 592 patients atteints d'insuffisance cardiaque à FEVG réduite (40 % ou moins), symptomatiques et déjà sous le traitement de fond actuel. Après un suivi moyen de 3,7 ans, le critère principal composite (hospitalisation pour aggravation, visite urgente conduisant à un traitement intraveineux ou par métolazone, transplantation, assistance ventriculaire gauche ou décès) est survenu chez 30,6 % des patients sous traitement actif contre 30,5 % sous placebo (HR 0,90 ; IC95 % 0,67–1,21 ; p = 0,48). Le traitement a été mal toléré : la dose cible n'a été atteinte à 6 mois que par une minorité des patients sous traitement actif, contre plus de la moitié sous placebo.

> **En pratique :** chez des patients en insuffisance cardiaque à FEVG réduite recevant le traitement de fond actuel, l'ajout d'hydralazine–dinitrate d'isosorbide n'a pas réduit le critère composite d'événements d'insuffisance cardiaque ou de décès, et le traitement a été mal toléré. Cet essai n'apporte donc pas d'argument en faveur de l'association dans cette population ; il n'a pas inclus de patients d'ascendance africaine et ne remet pas en cause les données antérieures obtenues chez eux. Le signal sur la mortalité, secondaire et non significatif, ne permet pas de conclure.

Article original

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL À connaître Essai randomisé · P4

Coronary CT Angiography versus Intravascular Ultrasound Guidance for PCI.

NEJM · 1er novembre 2026 · Essai randomisé ouvert de non-infériorité, 1 105 patients, international · TCT 2026

Cet essai de non-infériorité international, ouvert, à l'initiative des investigateurs et avec adjudication des événements en insu, a comparé une angioplastie guidée par le coroscanner et une angioplastie guidée par l'échographie endocoronaire (IVUS) chez 1 105 patients ayant une indication de revascularisation, au moins une sténose épicardique de plus de 70 % et une FFR dérivée du scanner inférieure ou égale à 0,80. À 12 mois, l'échec du vaisseau cible, qui associe décès cardiaque, infarctus du vaisseau cible et revascularisation du vaisseau cible motivée par l'ischémie, est survenu chez 4,1 % des patients du groupe coroscanner contre 4,6 % dans le groupe IVUS (différence −0,42 point ; IC95 % −2,82 à 1,99 ; p < 0,001 pour la non-infériorité). La supériorité n'a pas été démontrée (p = 0,73).

> **En pratique :** chez le patient dont le coroscanner avec FFR dérivée a déjà montré une sténose serrée et fonctionnellement significative, planifier et guider l'angioplastie à partir de ce scanner est une stratégie non inférieure au guidage par IVUS sur l'échec du vaisseau cible à un an, dans la marge de 4,5 points fixée par l'essai. Le résultat suppose un coroscanner interprétable et un logiciel de FFR dérivée, et il ne dit rien de la valeur du coroscanner par rapport à l'angiographie seule. Il ne démontre pas non plus de supériorité : le coroscanner apparaît comme une alternative possible au guidage endocoronaire, non comme un meilleur choix.

Article original · Analyse TCTMD

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL À connaître Essai randomisé · SEASON-AR

Transcatheter Aortic Valve Replacement in Pure Aortic Regurgitation: The Randomized SEASON-AR Clinical Trial.

Circulation · 31 octobre 2026 · Essai randomisé ouvert, 210 patients, 18 centres en Chine · TCT 2026

Cet essai randomisé ouvert multicentrique, mené dans 18 centres en Chine à l'initiative des investigateurs, a comparé le TAVI transfémoral avec la valve VitaFlow, associé au traitement médical optimal, et le traitement médical seul chez 210 patients porteurs d'une insuffisance aortique pure sévère, pour qui l'équipe médico-chirurgicale jugeait la chirurgie difficile ou inacceptable, ou qui la refusaient durablement. À un an, le critère principal associant décès toutes causes, AVC invalidant et réhospitalisation pour insuffisance cardiaque est survenu chez 8,3 % des patients du groupe TAVI contre 24,8 % sous traitement médical seul (HR 0,31 ; IC95 % 0,14–0,66 ; p = 0,001), la différence tenant essentiellement aux réhospitalisations pour insuffisance cardiaque (3,7 % contre 21,3 %). Le TAVI s'est accompagné de davantage d'hémorragies majeures ou menaçant le pronostic vital et d'implantations de stimulateur, survenues pour la plupart dans les 30 jours suivant la procédure.

> **En pratique :** chez le patient porteur d'une insuffisance aortique pure sévère que l'on ne peut pas opérer ou qui refuse la chirurgie, cet essai randomisé — aucun essai randomisé de puissance suffisante n'avait jusqu'ici comparé le TAVI au traitement médical seul chez ces patients — montre qu'un TAVI transfémoral ajouté au traitement médical réduit, à un an, le critère associant décès, AVC invalidant et réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Le bénéfice tient essentiellement aux réhospitalisations évitées, au prix d'un surcroît précoce d'hémorragies graves et de stimulateurs. Le résultat est obtenu dans un seul pays, avec une seule valve, sur 210 patients et un an de suivi : il ne concerne ni les patients opérables ni les autres dispositifs, et ne renseigne pas sur la durabilité.

Article original · Analyse TCTMD

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL Veille Essai randomisé · DUOTAP

Efficacy and Safety of Routine Postdilation in Balloon-Expandable Transcatheter Aortic Valve Implantation Platform: The DUOTAP Randomized Clinical Trial.

JAMA Cardiology · 3 novembre 2026 · Essai randomisé monocentrique en simple insu, 148 patients · TCT 2026

Cet essai randomisé monocentrique a comparé une post-dilatation systématique et une procédure simulée chez 148 patients traités par TAVI fémoral avec une valve expansible par ballon pour un rétrécissement aortique serré, sans facteur de risque anatomique au scanner ou à la coronarographie. La post-dilatation a réduit de 70 % l'indice d'asymétrie de la prothèse en fluoroscopie (médiane 1,2 % contre 2,8 % ; rapport des moyennes géométriques 0,30 ; IC95 % 0,18–0,47), avec des surfaces de prothèse plus grandes au scanner, moins d'épaississement hypo-atténuant des feuillets (HALT) à trois mois et moins de fuites paravalvulaires. Les complications procédurales à 30 jours ne différaient pas entre les groupes. Ce sont des critères d'imagerie et d'hémodynamique : l'effet sur les événements cliniques reste à démontrer.

> **En pratique :** chez des patients sélectionnés, sans anatomie à risque, la post-dilatation systématique d'une valve expansible par ballon donne une prothèse plus symétrique et plus ouverte, avec moins de HALT et de fuites paravalvulaires, sans excès de complications à 30 jours dans cet essai. Ces résultats plaident pour une post-dilatation systématique dans cette population, mais ils portent sur l'imagerie et l'hémodynamique : un bénéfice clinique à long terme reste à démontrer dans des essais plus larges.

Article original

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL Veille Essai randomisé · SINGLE-CLOSURE

Single vs Double ProGlide Devices for Access Site Closure after Transfemoral Aortic Valve Replacement: The SINGLE-CLOSURE Trial.

JACC · 3 novembre 2026 · Essai randomisé de non-infériorité, 25 centres, 876 patients · TCT 2026

Cet essai randomisé ouvert a comparé la fermeture de l'abord fémoral principal par un seul dispositif ProGlide et la stratégie classique à deux dispositifs chez 876 patients de 65 ans et plus traités par TAVI fémoral dans 25 centres. Le critère principal — les complications vasculaires majeures ou mineures du site d'abord pendant l'hospitalisation, selon la définition VARC-3 — est survenu chez 13,1 % des patients avec un seul dispositif contre 15,1 % avec deux, dans la marge de non-infériorité prédéfinie. Les complications majeures étaient rares dans les deux groupes (0,5 % contre 1,4 %), et l'essentiel des événements était mineur. La sténose du site de ponction était numériquement moins fréquente avec un seul dispositif, mais il a fallu un peu plus souvent ajouter un dispositif de fermeture.

> **En pratique :** dans cet essai, fermer l'abord fémoral du TAVI avec un seul ProGlide n'a pas entraîné davantage de complications vasculaires que la technique classique à deux dispositifs, et l'essentiel des événements observés était mineur. C'est un argument pour simplifier la fermeture de l'abord, en gardant la possibilité d'ajouter un dispositif si l'hémostase est insuffisante, ce qui a été nécessaire un peu plus souvent. Le gain sur la sténose du site d'abord n'est qu'une tendance et demande confirmation.

Article original

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL Veille Étude monobras · ENCIRCLE

Percutaneous Transcatheter Mitral Valve Replacement for Symptomatic Mitral Regurgitation: 2-Year Outcomes From the ENCIRCLE Trial.

JACC · 3 novembre 2026 · Étude monobras, 299 patients traités, suivi à 2 ans · TCT 2026

La cohorte principale de l'étude ENCIRCLE a suivi 299 patients porteurs d'une insuffisance mitrale symptomatique de grade 3+ ou plus, récusés pour la chirurgie et pour la réparation bord à bord, traités par remplacement valvulaire mitral percutané transseptal avec le système SAPIEN M3. À deux ans, la fuite restait réduite à un grade inférieur ou égal à 1+ chez 97,0 % des patients suivis, et 87,0 % étaient en classe NYHA I ou II. Le décès ou l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque sont survenus chez 35,6 % des patients, avec une mortalité toutes causes de 25,1 % ; thrombose de valve cliniquement significative et hémolyse nécessitant une intervention concernaient respectivement 7,1 % et 7,6 % des patients. Sans groupe témoin, ces résultats décrivent l'évolution des patients traités et ne mesurent pas un bénéfice par rapport à une autre prise en charge.

> **En pratique :** chez des patients soigneusement sélectionnés, récusés pour la chirurgie et la réparation bord à bord, le remplacement mitral percutané transseptal corrige la fuite de façon stable à deux ans et améliore les symptômes des survivants ; la mortalité toutes causes atteint toutefois 25 % à deux ans dans cette population à haut risque, et les thromboses de valve et les hémolyses ne sont pas rares. Sans groupe témoin, ces données ne permettent pas de situer cette option par rapport au traitement médical ou à d'autres techniques percutanées ; elles éclairent la discussion en équipe médico-chirurgicale pour les patients sans autre solution.

Article original

RYTHMOLOGIE Veille Essai randomisé · HOBIT-AF

A randomized comparison of comprehensive weight loss intervention vs. usual care on recurrences of atrial fibrillation in obese patients after catheter ablation: HOBIT-AF trial.

Europace · 4 novembre 2026 · Essai randomisé monocentrique ouvert, 167 patients

Cet essai randomisé a comparé un programme complet de perte de poids et la prise en charge habituelle chez 167 patients obèses (indice de masse corporelle 35,6 kg/m²) ablatés pour une fibrillation atriale, le plus souvent paroxystique ; le programme s'étendait du 3e au 18e mois après la procédure. Le groupe actif a perdu en moyenne 6,8 % de son poids initial et amélioré son profil métabolique, mais la charge en FA ou tachycardie atriale mesurée sur Holter de 14 jours n'a pas évolué différemment entre les groupes (+0,6 % contre −0,9 %). La survie sans récidive entre le 3e et le 18e mois était comparable, 70,4 % contre 69,6 %. Cette absence d'effet pourrait tenir à la faible charge en FA qui persiste après l'ablation, et qui laisse peu de marge d'amélioration.

> **En pratique :** chez le patient obèse dont la charge en FA est déjà faible, cet essai n'apporte pas d'argument pour attendre une baisse des récidives d'un programme de perte de poids commencé après l'ablation. Il ne remet pas en cause l'amélioration des paramètres métaboliques qui a accompagné la perte de poids, ni l'association, connue dans d'autres situations et non testée ici, entre réduction pondérale et charge en FA. Sa portée reste limitée par son caractère monocentrique et son effectif.

Article original

Fiches rédigées à l'aide de l'IA — résumés à valider par le lecteur avant toute application clinique, se reporter aux articles originaux.